要介護認定調査票・ペルソナ症例 01

要介護認定基本調査・主治医意見書・概況調査統合データファイル

1. 調査実施者および調査対象者の情報

調査対象者氏名	佐藤 トシ子（さとう としこ）	**年齢 / 性別**	82歳 / 女性
要介護度	要介護1	**調査実施者**	市町村委託ケアマネジャー（主任介護支援専門員）

2. 現在受けているサービスの状況（概況調査）

【在宅利用・介護給付】通所介護（デイサービス）週2回、訪問入浴週1回、福祉用具貸与（歩行器・手すり）

3. 置かれている環境等（家族・居住環境・傷病等）

【家族状況】夫（84歳・要支援1）と二人暮らし（老老世帯）。長男夫婦は車で30分に居住し週1回訪問。
【居住環境】持ち家（戸建て、玄関および室内に段差多少あり）。
【主な介護者】夫（ただし高齢のためお互いにサポートし合う状態）。
【傷病・既往歴】変形性膝関節症（両側）、腰部脊柱管狭窄症、高血圧症。

4. 主治医意見書（医学的記載事項）

主傷病名	変形性膝関節症（両側）、腰部脊柱管狭窄症、高血圧症
傷病の経過・治療内容	両膝関節の変形と疼痛が徐々に増強し、長距離の歩行が困難となっている。また腰部脊柱管狭窄症による間欠性跛行傾向あり。
医学的管理の必要性	鎮痛薬（NSAIDs等）の内服調整、定期的なヒアルロン酸ナトリウム膝関節内注射。血圧降下剤の内服による血圧管理。
身体障害に関する意見	両膝伸展制限および軽度屈曲拘縮あり。立位・歩行時に疼痛を伴うため、杖または手すり支持が必要。上肢機能は自立。
精神・認知機能の意見	認知機能は正常（HDS-R 26点相当）。見当識、記憶力に問題なく、意思疎通は円滑。
特別医療・ケアの必要性	日常的な特別医療処置は不要だが、疼痛コントロールおよび関節注射の継続が必要。転倒による骨折リスクに留意。
介護に関する医学的意見	基本調査の通り、家事全般や買い物における立位保持・移動に支援が必要。夫も要支援状態であるため、デイサービスや訪問入浴等の外部サービスを活用した生活機能維持が妥当。

5. 要介護認定基本調査（全74項目）

第1群：身体機能・起居動作（全13項目）

1. 麻痺（上肢）：なし (1)
2. 麻痺（下肢）：なし (1)
3. 関節拘縮（上肢）：なし (1)
4. 関節拘縮（下肢）：軽度あり（両膝伸展制限） (2)
5. 寝返り：自立 (1)
6. 起き上がり：自立 (1)
7. 座位保持：自立 (1)
8. 立位保持：つかまれば可能 (2)
9. 歩行：杖使用で可能（屋外・屋内とも） (2)
10. 立ち上がり：杖や手すりをつかまりながら可能 (2)
11. 片足立ち：困難 (3)
12. 洗顔（上肢の操作）：自立 (1)
13. 爪切り（手指の操作）：一部介助（老眼と指の変形のため家族が補助） (2)

第2群：生活機能（全12項目）

1. 移乗（ベッド⇔車いす等）：自立（ベッド利用なし、布団からの起立） (1)
2. 移動（屋内）：自立（杖または家具伝い） (1)
3. 移動（屋外）：一部介助（長距離は車椅子または付き添いが必要） (2)
4. 食事摂取：自立 (1)
5. 排泄（トイレ動作）：自立（夜間ポータブルトイレ使用時は見守り） (1)
6. 排泄（排便コントロール）：自立 (1)
7. 衣服着脱（上衣）：自立 (1)
8. 衣服着脱（ズボン等）：自立 (1)
9. 入浴：一部介助（浴槽への出入りにまたぎ動作の補助、洗身の一部補助） (2)
10. 口腔清潔（歯磨き等）：自立 (1)
11. 洗髪：一部介助（美容院利用または家族の洗髪補助） (2)
12. 買い物（日常の買物）：一部介助（重いものはネットスーパーや夫・息子が担当） (2)

第3群：認知機能（全9項目）

1. 意思の伝達：できる (1)
2. 麻痺等による意思伝達の困難さ：なし (1)
3. 短期記憶（直前の出来事の想起）：時々忘れるが日常会話は概ね成立 (2)
4. 日付の理解（今日の日付）：正確にわかる (1)
5. 場所の理解（自分のいる場所）：正確にわかる (1)
6. 自分の名前：わかる (1)
7. 生年月日：わかる (1)
8. 同行者の認識：家族の区別は確実につく (1)
9. 徘徊（外を歩き回る）：なし (1)

第4群：精神・行動障害（全15項目）

1. 薬の過量服薬：なし (1)
2. 収集癖（ゴミ等を溜め込む）：なし (1)
3. 落ち着きのない行動：なし (1)
4. 失敗に対するこだわり：なし (1)
5. 外出先での迷子：なし (1)
6. 介護への抵抗：なし (1)
7. 羞恥心の喪失（衣服を脱ぎ散らす等）：なし (1)
8. 不潔行為（排泄物の不適切処理等）：なし (1)
9. 異食（食べられないものを食べる）：なし (1)
10. 幻覚・妄想：なし (1)
11. 夜間不穏：なし (1)
12. 大声を出す：なし (1)
13. 徘徊（あてどなく歩く）：なし (1)
14. 興奮状態：なし (1)
15. 暴力行為：なし (1)

第5群：社会生活への適応（全6項目）

1. 薬の管理（服薬管理）：一部介助（一包化された薬の飲み忘れ防止に夫の声かけが必要） (2)
2. 金銭管理（お金の管理と買い物支払い）：自立 (1)
3. 簡単な調理（簡単な汁物やおかず）：一部介助（重い鍋の持ち運びや長時間の立ち作業が困難） (2)
4. 電話の利用（電話番号調べと通話）：自立 (1)
5. 社会的交流（近隣との付き合い、催しへの参加）：自立（近所付き合いは良好） (1)
6. 日常の意思決定（重要事項の決定）：自立 (1)

6. 特記事項（総合所見・ケアマネジメント留意点）

本人は認知機能に問題なく、自分の状態やリハビリの必要性も十分に理解している。しかし、両膝の変形性関節症に伴う慢性的な痛みと筋力低下により、家事全般（特に調理や洗濯干し）で長時間の立位保持ができない。夫も高齢（要支援1）であり、互いに補い合っているものの、買い物や重いものの持ち運び、および入浴時のまたぎ動作において外部サービス（デイサービス週2回、訪問入浴）の利用が必要不可欠となっている。